



Тренінг для керівників закладів охорони здоров'я з питань інтеграції послуг з ВІЛ (постконтактна профілактика постраждалим від гендерного насилля, послуг з тестування, до-контактна профілактика, попередження вертикальної передачі) на первинну ланку медичної допомоги в Львівській області.

Місце проведення: Готель «Дністер» м. Вул. Матейка 6, Львів, Україна.

Дата проведення 3-4 жовтня 2023

Посилання підключення до Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/82856928251?pwd=Q2N1d29EcGxZc2JjMFlyb2Z6ZXRYUT09>

Ідентифікатор конференції: 828 5692 8251

Пароль: 634127

ВВЕДЕННЯ

Україна є пріоритетною країною для прискорення масштабів лікування та догляду за ВІЛ для досягнення цільових показників щодо ВІЛ до 2025 року 95:95:95 та досягнення мети припинення епідемії СНІДу як загрози громадському здоров'ю до 2030 року та входить до числа країн із найвищим тягарем ВІЛ у Європейському регіоні ВООЗ. У Європейському регіоні ВООЗ, за показником частоти інфікування ВІЛ Україна посягає друге місце (37,1 нових випадків інфікування на 100 000 населення) за даними UNAIDS 2021р. Епідемія ВІЛ залишається сконцентрованою у ключових групах населення із поширеністю на рівні 20,5% серед людей, що вживають наркотики ін'єкційно (ЛВНІ), 3,1% — серед секс-працівників (СП) і 3,9% — серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками секс із чоловіками (ЧСЧ) (ІБПД, 2021 р.). Широкомасштабна військова агресія проти України спричинила непомірні виклики як для системи охорони здоров'я так і для населення яке потребує допомоги. Окрім загально відомих, гостро була визначена проблема надання допомоги жертвам насилля, в тому числі гендерно зумовленому насильству.

Гендерно зумовлене насильство (ГЗН) є однією з ключових проблем в Україні - за результатами досліджень 2 з 3 жінок в Україні зазнавали фізичного, психологічного або сексуального насильства (ОБСЄ, 2019). Більшість випадків насильства не фіксуються через стигму навколо цього явища в суспільстві та звинувачення постраждалої, недоліки інституційного середовища та соціально-економічні бар'єри (UNFPA, 2018; OSCE, 2019). Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну збільшило ризики ГЗН, особливо для жінок та дівчат з вразливих груп населення включно з поширенням випадків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом (СНПК) (ООН Жінки, 2022). За оцінками, 3,7 мільйонів людей в Україні потребують послуг пов'язаних з попередженням та протидією ГЗН у 2022 році (ОСНА, 2023). Ризики ГЗН включно з СНПК підвищені для населення, які залишаються в районах під військовим контролем Російської Федерації або в безпосередній близькості від зон

активних бойових дій. Іншими вразливими групами до ГЗН в контексті бойових дій є внутрішньо переміщені жінки та діти, особливо ті хто мешкають у місцях компактного проживання, та люди, які повернулися до районів, де було відновлено контроль Уряду України ([ОСНА, 2023](#)).

ГЗН має серйозні наслідки для фізичного, психологічного, сексуального та репродуктивного здоров'я постраждалих включно зі збільшенням ризику зараження ВІЛ ([ВООЗ, 2021](#)). Згідно з дослідженням ВООЗ, жінки, які зазнали фізичного або сексуального насильства, мали в 1,5 рази більше шансів мати інфекцію, що передається статевим шляхом, а в деяких регіонах і ВІЛ, порівняно з жінками, які не зазнавали насильства з боку партнера ([ВООЗ, 2021](#)). Медичні працівники відіграють важливу роль у наданні комплексної допомоги постраждалим від насильства. Вони часто є першою точкою професійного контакту для постраждалих та окрім надання медичної допомоги, можуть перенаправити постраждалих до соціальних, правових та інших послуг ([ВООЗ, 2021](#)).

У Львівській області, за даними ЦГЗ МОЗ України в 2022 році, 18,3% людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), не знали про свій статус; 24,9% осіб ЛЖВ, які зареєстровані в системі лікування, не отримували антиретровірусну терапію (АРТ), 19,6% осіб, які отримували АРТ не були обстежені на вірусне навантаження ВІЛ, серед обстежених 94,3% досягли вірусологічну супресію.

Для припинення епідемії ВІЛ у регіоні необхідно:

- збільшити охоплення послугами з тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника, у лікувальних закладів усіх рівнів медичної допомоги та особливо первинної ланки
- розширити надання ПТВ як за показаннями особливостей ризикованої поведінки та способу життя щодо інфікування ВІЛ так і за клінічними показаннями
- покращити доведення пацієнтів до надавачів ВІЛ послуг у разі отримання реактивного результату, а також у разі наявності показів до ДКП

З 2019 р. в Україні впроваджується «Національна Стратегія тестування на ВІЛ в Україні: 2019-2030 роки» (Стратегія), основною метою якої є розширення доступу до послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ). Основними базовими пріоритетними заходами стратегії є:

- забезпечити використання підходу надання ПТВ за ініціативою медичного працівника (тестування та консультування за ініціативи медичного працівника - ТКІМП) у ЗОЗ усіх рівнів та форм власності амбулаторного та стаціонарного профілів;
- забезпечити пропонування ПТВ усім пацієнтам із симптомами і станами, які вказують на імовірність ВІЛ-інфекції, включаючи підозрювані та підтверджені випадки туберкульозу, особам з ризикованою поведінкою та іншим категоріям населення відповідно до вимог законодавства.

В закладах охорони здоров'я Львівській області за 6 місяців 2023 року обстежено на ВІЛ 69777 осіб, з них осіб, у яких виявлено серологічні маркери ВІЛ – 321 особа (0,46%). Проведення подальшого масштабування тестування на ВІЛ на первинній ланці надання медичної допомоги за ініціативи медичного працівника, сприяє ранньому виявленню ВІЛ інфекції та швидкому призначенню АРТ. Виявлення ВІЛ на ранніх стадіях захворювання та своєчасне призначення

лікування, впровадження профілактичних заходів зменшує кількість осіб на пізніх стадіях та впливає на зменшення поширення ВІЛ серед населення в регіоні.

ВООЗ та Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України за підтримки CDC/PEPFAR, Глобального фонду та ЮНЕЙДС прагнуть до реагування системи охорони громадського здоров'я на ВІЛ-інфекцію та працюють разом над розширенням тестування та за ініціативи медичного працівника, призначення АРТ, збільшенням покриття до-контактною профілактикою.

МЕТА ТРЕНІНГУ

Надати керівникам установ та організаторам охорони здоров'я первинної ланки рекомендації з інтеграції до рутинної практики послуг протидії ВІЛ, а саме:

- послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ) за ініціативою медичного працівника
- надання медичної допомоги особам які постраждали від насилля у тому числі призначення постконтактної профілактики ВІЛ, ППСШ, гепатитів а також екстреного попередження небажаної вагітності
- тестування на ВІЛ за ініціативи медичного працівника,
- до-контактної профілактики ВІЛ
- попередження вертикальної передачі ВІЛ, сифілісу та гепатиту В
- запровадженню ефективного моніторингу означених станів

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ

1. Представити та обговорити наявні проблеми та перешкоди для ефективного надання ПТВ за ініціативою медичного працівника.
 - 1.1. Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ.
 - 1.2. Прогрес у досягненні цілей розширення доступу до ПТВ.
2. Презентація та обговорення рекомендацій щодо масштабування надання ПТВ за ініціативою медичного працівника.
 - 2.1. Особливості гендерного насильства. Декларація ООН, Конвенція ради Європи про запобігання насильству та боротьби з цими явищами, національне законодавство, яке регулює надання послуг постраждалим від ГЗН включно з медичним сектором, настанови ВООЗ щодо надання допомоги постраждалим від ГЗН.
 - 2.2. Настанови ВООЗ щодо тестування та лікування ВІЛ (включаючи останні оновлення).
 - 2.3. Національна стратегія тестування на ВІЛ в Україні.
 - 2.4. Профілактика попередження ВІЛ від матері до дитини, надання послуг з тестування на ВІЛ вагітним жінкам та їх партнерам.
 - 2.5. Звітування за результатами наданих послуг з тестування на ВІЛ.
3. Досягти консенсусної угоди щодо критично важливих втручань, а саме у:
 - 3.1. Приведенні у відповідність з сучасними алгоритмами тестування на ВІЛ діючих регіональних наказів, локальних протоколів та маршрутів пацієнтів
 - 3.2. Надання ПТВ з ініціативи медичного працівника в ЦПМСД за клінічними показаннями за клінічними показаннями
 - 3.3. Впровадженні клінічного маршруту пацієнта щодо тестування на ВІЛ, який забезпечує перенаправлення до ЗОЗ надавачів ВІЛ послуг, а саме до:
 - Отримання лікування у разі отримання реактивного результату

- Отримання послуг із ДКП у разі отримання адекватного результату та визначення показань
- 3.4. Забезпеченні інформуванням про можливість отримання до-контактної профілактики під час після тестової сесії
 - 3.5. Впровадженні моніторингу охоплення послугами з тестування на ВІЛ у ЦПМСД на підставі аналізу даних МІС.
 - 3.6. Забезпеченні інформуванням про можливість отримання до-контактної профілактики під час після тестової сесії
 - 3.7. Впровадженні моніторингу охоплення послугами з тестування на ВІЛ у ЦПМСД на підставі аналізу даних МІС.
4. Обговорити технічну підтримку, необхідну для надання ПТВ за ініціативою медичного працівника на первинній ланці надання медичної допомоги

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

По закінченню ТРЕНІНГУ учасники зможуть забезпечити організацію надання послуг:

1. З постконтактної профілактики ВІЛ, ПСШ та гепатитів особам які постраждалих від ГЗН, а також постраждалим від травм на робочому місці
2. З доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції;
3. З тестування на ВІЛ як по клінічним показанням та і з урахуванням особливостей ризикованої поведінки та способу життя щодо інфікування ВІЛ.
4. З тестування вагітних жінок та їх статевим партнерів для попередження вертикальної передачі ВІЛ, сифілісу та гепатиту
5. З моніторингу станів пов'язаних з ГЗН, постконтактної та доконтактної профілактики

ФАСІЛІТАТОРИ

Офіс ВООЗ в Україні, Європейське регіональне бюро ВООЗ

- Ігор Семененко, Національний спеціаліст з питань ВІЛ та гепатитів.
- Стриженко Олександра, Національна спеціалістка з питань лікування ВІЛ
- Тетяна Стариченко, Консультантка, національна експертка з лікування ВІЛ
- Дмитро Мирошніченко, Консультант, Національний експерт з тестування на ВІЛ
- Дарія Попова, Консультантка з питань гендеру, рівності та прав людини

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (ЦГЗ МОЗ) України.

- Лариса Гетьман, Завідувачка відділом координації програм діагностики та лікування ВІЛ,
- Олена Самсонова лікарка інфекціоніст відділу координації програм діагностики та лікування
- Марина Зубко, спеціаліст відділу статистики і аналізу

Мультидисциплінарна команда (МДК) Львівської області:

СПИСОК УЧАСНИКІВ (додається окремо)

Лікарі сімейної практики – ЦПМСД Львівської області.

- Рак Любомир Михайлович - голова МДК
- Ханас Ірина Юріївна - спеціаліст по моніторингу
- Сороколіт Андрій Любомирович - спеціаліст по тестуванню

- Кутинська Оксана Миколаївна - спеціаліст по лікуванню

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ

1. Зведені керівні принципи щодо профілактики, тестування, лікування, надання послуг та моніторингу ВІЛ-інфекції: рекомендації щодо підходу до охорони громадського здоров'я + додатки. ВООЗ, 2021. Неофіційний переклад українською мовою
2. Що таке 2+1+1? Пероральна доконтактна профілактика ВІЛ за потреби у чоловіків, що практикують секс із чоловіками. Оновлення рекомендацій ВООЗ щодо пероральної ДКП, 2019
3. Інструмент ВООЗ для реалізації програм доконтактної профілактики (ДКП) ВІЛ-інфекції. Модуль 1: Клінічний, 2017
4. Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Наказ МОЗ України №794 від 05.04.2019.
5. Стандарти медичної допомоги «ВІЛ-інфекція». Наказ МОЗ України №2092 від 16 .11. 2022.
6. Стандарт медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини». наказ МОЗ України №692 від 26.04.2022
7. Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги. Наказ МОЗ № 278 від 1 лютого 2019 р.
8. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 22 серпня 2018 р.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Дата 03 жовтня 2023

Час	Предмет	Ведучий/фасилітатор
9:00 – 10:00	Привітальне слово. Знайомство. Цілі ТРЕНІНГУ .	ВООЗ Центр громадського здоров'я
Сесія 1. Гендерно зумовлене насильство		
10:00 – 10:30	Розуміння ГЗН як проблеми у сфері громадського здоров'я	ВООЗ (презентація)
10:30 – 11:00	Огляд законодавства та алгоритм допомоги постраждалим від ГЗН	ВООЗ (презентація)
11.00 – 11.30 Перерва на каву		
11:30 – 12:15	Алгоритм допомоги постраждалим від ГЗН: постконтактна профілактика включно з профілактикою ВІЛ	ВООЗ Фасилітована дискусія у великих групах
12:15 – 13:00	Практична вправа: розуміння досвіду особи, що постраждала від насильства, та впливу цінностей і переконань надавачів послуг	ВООЗ (практична вправа “Під тягарем провини”)
13.00 – 14.00 обід		
Сесія 2. Надання послуг з тестування на ВІЛ		
14:00 – 14:20	Керівництво ВООЗ щодо тестування та діагностики ВІЛ: Алгоритми тестування використання трьох тестів для встановлення діагнозу	ВООЗ (презентація)
14:20 – 14:40	Національна стратегія тестування на ВІЛ в Україні. Тестування на ВІЛ згідно з законодавством України	ЦГЗ МОЗ України (презентація)
14:40 – 15:00	Тестування на ВІЛ в Львівській області.	Львівської області (презентація) МДК
15:00 – 15:30	Алгоритми надання послуг з ДКП та ПКП	ЦГЗ МОЗ України (презентація) офлайн
15:30 – 16:00 Перерва на каву		
16:00 – 17:00	Практична вправа. Приклади до-тестового інформування (ДТІ) та після тестового консультування (ПТК) у разі отримання реактивного та адекватного результатів тесту на ВІЛ. Рольові вправи: надання ДТІ ПТК Проведення тестування ШТ.	ВООЗ/ЦГЗ МОЗ України МДК Львівської області (демонстрація фасилітаторів, рольові вправи в малих групах по 4 учасника з одним фасилітатором)

Дата 04 жовтня 2023

Час	Предмет	Ведучий/фасилітатор
9:00 – 09:15	Привітання Підсумок першого дня зустрічі	ВООЗ Центр громадського здоров'я

Сесія 3 Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини		
9:15 – 9:35	Елімінація передачі від матері до дитини ВІЛ інфекції, гепатиту В, сифілісу	ВООЗ (презентація глобальна концепція)
9:35 – 10:05	Програма Елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ інфекції, гепатиту В, сифілісу в Україні	ЦГЗ МОЗ України
10:05 – 10:25	Програма Елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ інфекції в Львівській області	МДК Львівської області
10:25 – 11:00	Тестування на ВІЛ вагітних, після тестове консультування, спостереження за вагітними з ВІЛ	МДК (презентація)
11.00 – 11.30 Перерва на каву		
11:30 – 12:00	Фасилітована дискусія: консультування вагітної жінки при реактивному результаті тестування	МДК Львівської області (Фасилітатор залучає учасників до дискусії щодо консультування, скерування, спостереження)
12.00 – 13.00 обід		
Сесія 4. Моніторинг даних щодо ГЗН, ПТВ, ДКП, ПКП, ЕПМД		
13:00 – 14.30	Склад та структура звітів на основі вимог до їх подання щодо ГЗН, ДКП, ПКП, ЕПМД, та порядок обліку	ЦГЗ МОЗ України
14:30 – 15:00	Практична вправа: Заповнення звітних форм з ГЗН, ДКП, ПКП, ЕПМД,	ЦГЗ МОЗ України
15:00 – 15:30 Перерва на каву		
15:30 – 16:00	Підведення підсумків зустрічі Вручення сертифікатів	ВООЗ, ЦГЗ МОЗ України